

## 高血压的预防与管理指南

### 一、定义与分级

高血压定义为：在未使用降压药物的情况下，非同日 3 次测量诊室血压，收缩压 $\geq$ 140mmHg 和/或舒张压 $\geq$ 90mmHg。

分级标准：

- 正常血压：<120/80 mmHg
- 正常高值：120-139/80-89 mmHg
- 1 级高血压：140-159/90-99 mmHg
- 2 级高血压：160-179/100-109 mmHg
- 3 级高血压： $\geq$ 180/110 mmHg

### 二、危险因素

1. 不可控因素：年龄、遗传、性别

2. 可控因素：

- 高盐饮食 (>5g/天)
- 肥胖 (BMI $\geq$ 28)
- 缺乏运动
- 过量饮酒
- 长期精神紧张
- 吸烟

### 三、非药物治疗

1. 饮食调整：DASH 饮食法

- 多蔬菜水果：每日 400-500g
- 低脂乳制品：每日 300ml

- 全谷物替代精制谷物
- 限制钠盐：<5g/天
- 适量坚果、豆类

## 2. 运动建议：

- 有氧运动：每周 5-7 次，每次 30 分钟
- 中等强度：心率达到  $(220 - \text{年龄}) \times 60\% - 70\%$
- 推荐：快走、游泳、骑自行车

## 3. 体重管理：

- 减重目标：5%-10%当前体重
- 腰围控制：男性<90cm，女性<85cm

## 四、药物治疗

### 一线降压药物：

1. ACEI/ARB：普利/沙坦类，适合糖尿病、心衰患者
2. CCB：地平类，适合老年、单纯收缩期高血压
3. 利尿剂：氢氯噻嗪，适合水肿、心衰
4.  $\beta$ 受体阻滞剂：洛尔类，适合心绞痛、心梗后

### 用药原则：

- 小剂量开始，逐渐调整
- 优先长效制剂，平稳降压
- 联合用药优于大剂量单药
- 长期坚持，勿自行停药

## 五、监测与随访

1. 家庭自测血压：早晚各 1 次，每次测量 2-3 遍取平均值
2. 随访频率：
  - 初诊/调药期：每 2-4 周
  - 血压控制稳定：每 3-6 个月
3. 年度检查：心电图、尿常规、肾功能、眼底检查

血压控制目标：

- 一般患者：<140/90 mmHg
- 糖尿病/肾病患者：<130/80 mmHg
- 老年人（ $\geq 65$  岁）：<150/90 mmHg